

Trombose venosa profunda · diagnóstico e anticoagulação

TVP proximal exige anticoagulação pronta se não houver contraindicação. Use probabilidade pré-teste + USG; trombólise/filtro de VCI são exceções.

Proximal × distal

Lembre - Proximal × distal

Íliaco-femoral-poplítea: tratar. Distal isolada: pode observar com USG seriado em baixo risco ou anticoagular conforme sintomas/extensão — bancas variam; priorize proximal.

Baixa probabilidade pode usar D-dímero; alta vai à imagem e anticoagulação.

Suspeita de TVP

Wells -> exame -> tratar



Conduta

- Anticoagulação "e3 meses na provocada; mais longa se não provocada/recorrente/câncer
- DOAC preferencial em muitos cenários ambulatoriais elegíveis
- Gestação: HBPM (sem DOAC/varfarina no 1ºT conforme regra)
- Filtro de VCI: contraindicação à anticoagulação ou falha documentada

Sinais e fatores

Item | Exemplos

Clínica | Edema assimétrico, dor, cordão, calor

Provocadores | Cirurgia, imobilização, câncer, viagem longa

Exame | USG compressivo duplex

Complicação | TEP, síndrome pós-trombótica

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não massageie a perna nem atrase anticoagulação esperando 'confirmação perfeita' em alta probabilidade com USG positivo. Investigar câncer oculto de forma dirigida, não painel cego universal.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

TVP: probabilidade pré-teste com Wells !' D-dímero ou Doppler. Anticoagular conforme risco e contraindicações.

Some pontos; diagnóstico alternativo tão ou mais provável subtrai 2. Corte clássico: <2 improvável; "e2 provável (ou regras de 2 níveis).

Wells - TVP

Probabilidade pre-teste

Cancer ativo	1
Paralisia / imobilização recente MMII	1
Cirurgia / acamado >3d (4 sem)	1
Dor no trajeto venoso profundo	1
Edema de toda a perna	1
Edema panturrilha >3 cm	1
Edema com cacifo no lado sintomático	1
Veias superficiais colaterais	1
TVP previa documentada	1
Diagnóstico alternativo tão provável	-2

<2 improvável | ≥2 provável (-2 se alt. diagnóstico)

Fluxo

Lembre - Fluxo

Wells baixo + D-dímero negativo "H exclui. Wells alto ou D-dímero positivo !' USG compressão (Doppler). Não atrase anticoagulação se alta probabilidade e sem contraindicação enquanto espera exame.

Conduta

- Anticoagulação (DOAC ou heparina !' varfarina conforme cenário)
- Duração típica: 3 meses se provocada; mais longa se não provocada/recorrente/câncer
- Filtro de VICava: contraindicação à anticoagulação + TVP proximal / embolia
- Pense TEP se dispneia/dor torácica

Diferenças úteis

Quadro | Pista

TVP | Edema assimétrico, dor panturrilha, Wells

Celulite | Eritema quente, febre local

Ruptura de cisto de Baker | Dor súbita; USG diferencia

Profilaxia

Dica - Profilaxia

Cirurgia / hospitalização: meias + HBPM/DOAC conforme risco. Ponto clássico pós-op ortopédico e oncológico.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1